

// PRIMEIROS SOCORROS

PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES **EXTREMAS**

POR CLODOALDO C SILVA

CAPÍTULOS

01	Avaliação de Cena: segurança primeiro	
02	Queimaduras por Calor e Químicos	
03	Picadas de Animais Peçonhentos	
04	Insolação e Desidratação Severa	
05	Hipotermia: rewarming ativo e passivo	
06	Trauma de Mãos e Olhos	
07	Hipotermia: rewarming ativo e passivo	
08	Trauma de Mãos e Olhos	
09	Choque Anafilático em Ambiente Remoto	
10	Evacuação: quando e como transportar	
11	Choque Anafilático em Ambiente Remoto	
12	Evacuação: quando e como transportar	



CAPÍTULO 1: AVALIAÇÃO DE CENA: SEGURANÇA PRIMEIRO

Sempre que se depara com uma situação de emergência, o primeiro instinto é correr para ajudar. Errado. Antes de tocar em qualquer pessoa, você precisa garantir que a área ao seu redor é segura. Avaliar a cena é o passo mais importante. Pense em você: se você se machucar, a situação piora e ninguém será ajudado. Olhe ao redor. Há perigo imediato, como fogo, animais peçonhentos, trânsito intenso, ou estruturas instáveis que possam desmoronar? Se houver, afaste-se e chame ajuda profissional antes de qualquer coisa. A sua segurança é o alicerce de todo o socorro que você pode prestar.

Uma vez que a área está segura, aproxime-se da vítima com cuidado. Verifique se ela está consciente chamando por seu nome e batendo levemente em seus ombros. Uma vítima inconsciente representa um risco maior, pois pode não estar respirando. Ao se aproximar, observe o ambiente imediato. A vítima pode ter caído de uma árvore, sido picada por uma cobra ou atingida por um raio. O contexto da cena pode dar pistas cruciais sobre os ferimentos e os tratamentos necessários, sem mencionar os perigos que ainda podem persistir.

A avaliação rápida da vítima segue o protocolo ABC. A (Airways) - Verifique se a via aérea está desobstruída. B (Breathing) - Veja se a vítima está respirando normal e com força. C (Circulation) - Procure por hemorragias visíveis. Essa rápida triagem ajuda a priorizar as ações. Se a vítima não está respirando, a prioridade é a reanimação cardiorespiratória. Se há sangramento grave, o controle da hemorragia vem em primeiro lugar. Não tente resolver tudo de uma vez; foque no que é mais mortal.

Exemplo prático: Em uma trilha no Parque Nacional da Chapada Diamantina, você encontra um turma caído de uma pequena cachoeira. Antes de descer, você verifica se há pedras soltas na encosta e se a água está forte demais. Ao chegar, pergunta 'Você consegue me ouvir?'. Ele murmura, está consciente. Você nota uma perna torta e um corte no braço que sangra. Dica de segurança: Nunca mova uma vítima com suspeita de fratura ou lesão na coluna, a menos que o local esteja perigosíssimo. Erro comum: Pular a avaliação da cena para focar na vítima, colocando-se em risco e piorando a situação. Checklist de Segurança: 1. O local está estável? 2. Há perigo imediato? 3. A vítima está consciente? 4. Há sinais de vida? 5. Quais são os ferimentos aparentes?



CAPÍTULO 4: QUEIMADURAS POR CALOR E QUÍMICOS

Queimaduras são lesões comuns na natureza, causadas pelo contato direto com fogo, água quente, objetos quentes ou substâncias químicas. No Brasil, o sol forte e o manuseio de fogueiras são causas frequentes. O primeiro passo em qualquer queimadura é garantir a segurança do local e do socorrista. Em seguida, avalie a extensão e a profundidade da lesão. Queimaduras leves atingem apenas a camada externa da pele, enquanto as graves podem afundar músculos e ossos. A reação inicial deve ser sempre de resfriamento, pois isso alivia a dor e previne danos mais profundos ao tecido. Jamais use gelo ou água gelada diretamente, pois isso pode causar mais dano.

Para queimaduras por calor, o procedimento é simples e eficaz. Lave a área afetada com água corrente fria por pelo menos 15 minutos. O objetivo é reduzir a temperatura da pele e diminuir a dor. Se a vítima estiver em uma área sem água, use qualquer líquido disponível, como suco de abacaxi ou coca-cola, que podem ajudar a resfriar e até mesmo esterilizar a ferida em casos de emergência. Após o resfriamento, cubra a área com um pano limpo e úmido ou um curativo estéril para proteger da infecção. Não use algodão, pois as fibras podem grudar na ferida.

Em queimaduras químicas, o procedimento é diferente e urgente. A substância química precisa ser removida imediatamente da pele. Use água em abundância para enxaguar a área por pelo menos 20 minutos. Se possível, identifique o produto químico para informar aos socorros médicos. Remova roupas contaminadas com cuidado para não espalhar o produto. Não use produtos neutros como vinagre ou bicarbonato, pois podem reagir de forma negativa com o químico. O foco total é a diluição e remoção do agente agressor.

Exemplo prático: um guia turístico tropeça e cai em uma fogueira, sofrendo queimaduras nas pernas. O primeiro socorro deve ser afastá-lo da fogueira e imediatamente despejar água fria da catinga sobre as áreas afetadas por 15 minutos. Depois, cobrir com um pano de algodão úmido. Dica de segurança: sempre tenha um kit de primeiros socorros com curativos estéreis e luvas no seu equipamento de trilha. Erro comum: aplicar pomatas ou manteigas na queimadura, o que pode causar infecção. Checklist: 1. Segurança do local, 2. Resfriamento com água, 3. Cobertura com pano limpo, 4. Buscar ajuda médica.



CAPÍTULO 5: PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS

No Brasil, a fauna peçonhenta é diversa e perigosa, cobras, escorpiões, aranhas e abelhas são comuns em ambientes naturais. Em uma situação de sobrevivência, o conhecimento sobre esses animais é tão importante quanto o tratamento da picada. O primeiro passo é manter a calma. A pior reação é o pânico, que acelera a circulação e espalha o veneno mais rapidamente pelo corpo. Identifique o animal, se possível, pois essa informação é crucial para os socorros. Em seguida, afaste a vítima do local para evitar novas picadas e comece o tratamento imediato.

O tratamento inicial para picadas de cobra e escorpião foca na contenção do veneno. Afrouxe roupas e joias apertadas para não dificultar a circulação. A vítima deve permanecer imóvel, de preferência deitado, para diminuir o fluxo sanguíneo para a área afetada. Limpe a ferida com água e sabão se disponível. Jamais faça um garrote ou tente sugar o veneno, pois isso é ineficaz e agrava o dano tecidual. O objetivo é retardar a absorção do veneno, não removê-lo.

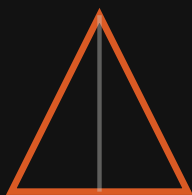
Para picadas de abelhas e vespas, a primeira ação é remover o ferrão. Esfregue a área com a borda de uma unha ou uma lâmina fina para arrancar o ferrão junto com a vesícula de veneno. Não aperte o ferrão com as mãos, pois isso injeta mais veneno. Após a remoção, lave a área com água e sabão e aplique um pano frio para diminuir a dor e o inchaço. Se a vítima apresentar reações alérgicas como dificuldade de respirar ou inchaço no rosto, é uma emergência que exige ação imediata.

Exemplo prático: um caçador é picado por uma jararaca na perna durante uma caminhada na Serra da Mantiqueira. O primeiro socorro deve ser sentar a vítima, afrouxar a calça e mantê-la tranquila. Não se deve fazer um torniquete. A perna deve ser imobilizada e a vítima transportada para o hospital o mais rápido possível. Dica de segurança: use botas cano alto e calça comprida em áreas de mata para reduzir o risco de picadas. Erro comum: cortar a área da picada e sugar o veneno, o que causa infecção e hemorragia. Checklist: 1. Identificar o animal, 2. Imobilizar a vítima, 3. Remover ferrão (se houver), 4. Buscar ajuda médica.

// 03

ÁGUA É VIDA

CAPÍTULOS A SEGUIR



CAPÍTULO 6: INSOLAÇÃO E DESIDRATAÇÃO SEVERA

O calor intenso do Brasil pode causar insolação e desidratação, condições sérias que podem ser fatais se não tratadas rapidamente. A insolação ocorre quando o corpo não consegue regular sua temperatura, subindo a mais de 40 graus Celsius, enquanto a desidratação é a perda excessiva de líquidos e sais. Ambas as condições são comuns em trilhas, praias e áreas abertas, especialmente durante o verão. Reconhecer os sinais precoces é fundamental para evitar um colapso. Os primeiros sintomas são sede intensa, tontura, dor de cabeça e pele suada e fria.

O tratamento para a insolação é urgente e focado no resfriamento do corpo. Mova a vítima para um local fresco e sombrio. Retire roupas e calçados para facilitar a evaporação do suor. Aplique água fria na pele, especialmente na cabeça, no pescoço e nas axilas. Use panos úmidos e ventilé-la com um leque ou qualquer objeto disponível. Se a vítima estiver consciente, ofereça pequenos goles de água ou solução de reidratação oral. Não a force a beber grandes quantidades de água de uma só vez.

Para desidratação severa, o foco é repor líquidos e eletrólitos. A vítima pode apresentar boca seca, olhos fundos, urina escura e confusão mental. A melhor solução é a água com sal e açúcar, conhecida como soro caseiro. Para prepará-la, misture um litro de água potável, uma colher de sopa de sal e oito colheres de sopa de açúcar. Ofereça pequenas quantidades frequentemente. Se a vítima estiver inconsciente ou vomitando, não tente alimentá-la ou hidratá-la pela boca, pois o risco de engasgo é alto.

Exemplo prático: um grupo de turistas fica perdido na Chapada dos Veadeiros e um deles começa a sentir tontura e confusão sob o sol forte. O guia deve imediatamente levá-lo para debaixo de uma árvore, tirar a camisa dele e molhá-lo com água da catinga. Em seguida, prepara um soro caseiro com a água que tem e oferece para a vítima beber aos poucos. Dica de segurança: beba água constantemente antes de sentir sede, mesmo que não tenha sede. Erro comum: dar bebidas açucaradas como refrigerante para desidratados, o que piora a perda de líquidos. Checklist: 1. Identificar sinais de insolação/desidratação, 2. Levantar para local fresco, 3. Resfriar e repor líquidos, 4. Buscar ajuda se não melhorar.



CAPÍTULO 7: HIPOTERMIA: REWARMING ATIVO E PASSIVO

A hipotermia é uma queda perigosa da temperatura corporal, um inimigo silencioso que pode se instalar rapidamente em ambientes de mata ou montanha brasileiros, especialmente em dias chuvosos ou ao amanhecer. Reconhecer os sinais é o primeiro passo para salvar uma vida. A pessoa fica com tremores intensos, fala de forma arrastada, fica letárgica e, em casos graves, para de tremer completamente, indicando que o corpo está desligando o sistema de aquecimento. Nesses momentos, agir rápido e com a técnica certa é fundamental para evitar danos permanentes ou a morte. O objetivo é restaurar a temperatura corporal de forma segura e gradual.

O resfriamento passivo é a primeira medida a ser tomada. Consiste em parar a perda de calor da vítima. Remova qualquer roupa molhada, pois a água retira o calor do corpo muito mais rápido que o ar. Seque a pele e cubra a pessoa com mantas, sacos de dormir ou até mesmo folhas de palmeira grandes e secas. O importante é criar uma barreira isolante entre o corpo e o ambiente frio. Mantenha a cabeça e o pescoço cobertos, pois perdem uma quantidade significativa de calor. Em uma situação de campo, o uso de cobertores de emergência, que refleitam o calor do corpo, é altamente eficaz.

O resfriamento ativo é o próximo passo, especialmente se a vítima está consciente e com tremores. Envie calor para o corpo dela de forma direta. A melhor fonte é o calor humano: deite a vítima ao lado de uma pessoa sadia e seca, permitindo que o calor corporal seja transferido. Outra excelente técnica é preparar garrafas de água quente (não fervente, para não queimar) e colocá-las nas axilas, no pescoço e na virilha, que são áreas com grandes vasos sanguíneos próximos à pele. Isso ajuda a aquecer o sangue que circula por todo o corpo de forma mais eficiente.

Dica de segurança: Nunca massageie as extremidades de uma pessoa com hipotermia grave, pois isso pode redirecionar o sangue frio para o coração, causando uma queda brusca da pressão. Um erro comum é dar bebidas alcoólicas, pois o álcool dilata os vasos sanguíneos, acelerando a perda de calor. Checklist: 1. Remover roupa molhada. 2. Secar e cobrir completamente. 3. Aquecer o torso primeiro. 4. Oferecer bebida quente não alcoólica. 5. Buscar ajuda médica imediatamente. Exemplo prático: Durante uma caminhada na Serra da Mantiqueira, seu parceiro começa a tremer violentamente e se queixa de frio intenso.

Você o retira para um abrigo seco, retira sua camisa molhada, o cobre com duas mantas e posiciona duas garrafas de água quente no peito e nas axilas, enquanto o aquece com seu próprio corpo.



CAPÍTULO 10: TRAUMA DE MÃOS E OLHOS

Mãos e olhos são os órgãos mais vulneráveis em ambientes hostis. Uma queda na mata pode rasgar a pele com galhos, enquanto um arranhão de cipó pode causar infecção grave. Para lesões oculares, a primeira reação não deve ser coçar ou esfregar o olho, pois isso agrava o dano. O procedimento correto é enxaguar abundantemente com água potável ou, na falta dela, com água estéril, como a de uma seringa sem agulha. Mantenha a cabeça parada e o olho afetado fechado. Em casos de corpo estranho penetrante, não tente retirar nada. Use uma proteção limpa, como um lenço, para cobrir o olho e evitar movimentos. Em uma trilha no Parque Nacional da Chapada Diamantina, um turista foi atingido por um galho. O guia imediatamente cobriu o olho dele com uma bandana e evitou qualquer manipulação, garantindo atendimento especializado sem complicar o trauma.

Para lesões nas mãos, como cortes ou lacerações, a prioridade é controlar o sangramento. Eleve a mão acima do nível do coração para diminuir o fluxo sanguíneo. Use um curativo limpo e pressione firmemente na ferida. Se o sangramento não parar, aplique uma bandagem elástica com pressão moderada. Lave a ferida com água limpa para remover sujeira e detritos. Em uma expedição na Amazônia, um caçador cortou o dedo com uma facção. O guia usou água de um córrego filtrada para limpar a área, aplicou um curativo estéril e imobilizou o dedo com uma tala de madeira para evitar movimentos que causassem mais sangramento.

Dica de segurança: Sempre carregue um kit de primeiros socorros com itens básicos como gaze, esparadrapo, tesoura e luvas. Isso pode fazer a diferença entre uma recuperação rápida e complicações graves. Um erro comum é subestimar a gravidade de um arranhão ou um corte pequeno na mão. Mesmo feridas aparentemente simples podem se infectar facilmente em ambientes úmidos e sujos, levando a complicações sérias como celulite ou septicemia.

Checklist para Trauma de Mãos e Olhos: - Não esfregar o olho ferido - Enxaguar com água limpa - Cobrir o olho com proteção se houver corpo estranho - Elevar a mão para controlar sangramento - Lavar feridas com água potável - Aplicar curativo estéril - Imobilizar a área com tala se necessário - Monitorar sinais de infecção como vermelhidão, calor ou pus

// 06

GRADE CINCO TEMAS

CAPÍTULOS A SEGUIR



CAPÍTULO 7: HIPOTERMIA: REWARMING ATIVO E PASSIVO

A hipotermia ocorre quando o corpo perde calor mais rápido do que consegue produzir, resultando em temperatura central abaixo de 35°C. O tratamento depende da gravidade, mas o rewarming, ou aquecimento, é essencial. O rewarming passivo envolve remover roupas molhadas e cobrir a vítima com mantas térmicas ou cobertores. Este método é adequado para casos leves, onde o corpo consegue reaquecer naturalmente. Já o rewarming ativo é necessário em hipotermia moderada a grave. Ele inclui o uso de calor externo, como bolsas de água quente ou cobertores elétricos, aplicados nas áreas do tronco, axilas e virilhas. Em casos graves, o rewarming interno pode ser necessário, com a administração de fluidos aquecidos por via intravenosa.

Exemplo prático: Um alpinista é encontrado com tremores intensos e confusão após uma noite exposto ao frio. Primeiro, remova roupas molhadas e seque a pele. Em seguida, envolva-o em duas mantas térmicas, aplicando uma bolsa de água quente no tronco. Monitore a temperatura retal a cada 15 minutos. Se a temperatura não subir, considere rewarming ativo com fluidos quentes.

Dica de segurança: Nunca use calor direto, como lâmpadas ou aquecedores, em casos de hipotermia grave, pois pode causar queimaduras ou parada cardíaca devido à vasodilatação repentina.

Erro comum: A tentativa de massagear os membros da vítima para estimular o fluxo sanguíneo. Isso pode deslocar o frio para o coração, agravando a condição.



CAPÍTULO 10: TRAUMA DE MÃOS E OLHOS

As mãos e os olhos são áreas extremamente sensíveis e vulneráveis a traumas em situações extremas. Lesões nessas regiões podem comprometer a capacidade de sobrevivência e demanda atenção imediata. Para lesões oculares, evite esfregar os olhos ou aplicar pressão. Em vez disso, cubra o olho afetado com um curativo limpo e solto para evitar movimentos. Se houver corpo estranho, não tente removê-lo, pois isso pode causar danos maiores. Para cortes ou perfurações nas mãos, aplique pressão direta com um pano limpo para controlar o sangramento. Não use laços apertados, pois podem restringir a circulação. Após estabilizar, eleve a mão acima do nível do coração para reduzir o fluxo sanguíneo. Exemplo prático: Em acidentes com ferramentas, um corte profundo no dedo pode ocorrer. A pressão direta com um pano limpo é essencial enquanto se busca ajuda. Dica de segurança: Mantenha uma caixa de primeiros socorros com luvas limpas e curativos estéreis para evitar infecções. Erro comum: Tentar remover um corpo estranho do olho com objetos pontiagudos, o que agrava a lesão.



CAPÍTULO 11: CHOQUE ANAFILÁTICO EM AMBIENTE REMOTO

O choque anafilático é uma reação alérgica grave que pode ser fatal se não tratada rapidamente. Em ambientes remotos, onde o acesso a ajuda médica é limitado, a ação imediata é crucial. Os principais sintomas incluem dificuldade para respirar, inchaço na garganta, queda de pressão e desmaio. O primeiro passo é administrar adrenalina se disponível, via injeção intramuscular na coxa. Mantenha a pessoa deitada com as pernas elevadas para melhorar a circulação. Se a pessoa parar de respirar, inicie compressões torácicas. Exemplo prático: Uma pessoa picada por uma abelha em uma trilha pode desenvolver sintomas de anafilaxia. A aplicação rápida de adrenalina pode salvar sua vida até chegar a um hospital. Dica de segurança: Sempre leve um kit de adrenalina em ambientes remotos e informe alguém sobre suas alergias antes de sair. Erro comum: Atrasar a administração de adrenalina esperando sintomas piores, o que pode levar ao agravamento do quadro.

// 09

SEU FUTURO É PREPARAÇÃO

CAPÍTULOS A SEGUIR



CAPÍTULO 12: EVACUAÇÃO: QUANDO E COMO TRANSPORTAR

A evacuação é uma decisão crítica em situações extremas, pois transportar uma pessoa lesionada de forma inadequada pode piorar seu estado. A evacuação é necessária quando a vítima está em um local inseguro, como em uma área de desastre, ou quando precisa de cuidados médicos especializados. Antes de mover a pessoa, avalie os riscos: se há risco de incêndio, desmoronamento ou outros perigos imediatos. Para transportar, use técnicas como o arrasto de segurança para distâncias curtas ou uma maca improvisada para distâncias maiores. Sempre mantenha o alinhado da coluna, especialmente em suspeita de lesão na coluna vertebral. Exemplo prático: Em uma montanha, uma pessoa com uma perna fraturada precisa ser deslizada para uma área segura antes de usar uma maca improvisada com mantas e galhos. Dica de segurança: Nunca tente carregar uma pessoa sozinho; sempre peça ajuda para evitar lesões adicionais. Erro comum: Mover uma pessoa com suspeita de lesão na coluna sem a devida imobilização, o que pode causar danos permanentes.



CAPÍTULO 11: CHOQUE ANAFILÁTICO EM AMBIENTE REMOTO

O choque anafilático é uma reação alérgica severa e potencialmente fatal que pode ocorrer em questão de minutos após exposição a um alérgeno — picadas de insetos, alimentos, medicamentos ou contato com plantas. Em ambiente remoto, longe de hospitais, saber reconhecer e tratar esta condição é literalmente uma questão de vida ou morte.

Os sinais de anafilaxia incluem: inchaço dos lábios, língua e garganta (edema de vias aéreas), dificuldade para respirar (broncoespasmo), urticária generalizada, queda de pressão arterial, taquicardia, tontura e sensação de morte iminente. A progressão pode ser tão rápida que em 5-10 minutos a vítima perde consciência.

Exemplo prático: um membro da expedição é picado por uma abelha. Em 3 minutos, o rosto começa a inchar. Em 5 minutos, há dificuldade respiratória. O protocolo é: administrar epinefrina (adrenalina) IM na coxa, 0,3mg para adulto, repetir após 5 minutos se não houver melhora. Posicionar a vítima deitada com pernas elevadas. Manter vias aéreas abertas.

Dica de segurança: carregue sempre uma caneta de epinefrina (EpiPen) no kit de primeiros socorros, especialmente em áreas com abelhas, vespas ou plantas alergênicas. Verifique a validade periodicamente. Em ambiente remoto, sem epinefrina, anti-histamínicos como difenidramina podem ajudar em reações leves, mas NÃO substituem a adrenalina em casos graves.

Erro comum: subestimar a gravidade de uma reação alérgica. Uma urticária leve pode evoluir para anafilaxia em minutos. Se houve qualquer dificuldade respiratória, trate como emergência máxima. A janela de intervenção é de minutos, não horas.



CAPÍTULO 12: EVACUAÇÃO: QUANDO E COMO TRANSPORTAR

A decisão de evacuar uma vítima de um ambiente remoto para um centro médico é uma das mais complexas na medicina de campo. Evacuar cedo demais pode expor a vítima a riscos adicionais; evacuar tarde demais pode custar uma vida. Avaliar corretamente é fundamental.

Critérios para evacuação IMEDIATA: fratura exposta, hemorragia não controlada, traumatismo craniano com perda de consciência, queimaduras de segundo grau em mais de 20% do corpo, sinais de choque, dificuldade respiratória persistente, picada de cobra peçonhenta, suspeita de hemorragia interna.

Critérios para evacuação NÃO imediata (mas necessária): entorse moderada sem fratura, cortes suturáveis, queimaduras de primeiro grau extensas, desidratação moderada, febre persistente. Nestes casos, monitore a vítima a cada 30 minutos e decida com base na evolução.

Exemplo prático: um companheiro cai de uma altura de 3 metros e queixa de dor no peito. Pode caminhar, mas tem respiração curta. Decisão: evacuação imediata — risco de fratura de costelas com comprometimento pulmonar. Improvise uma maca com galhos e corda, ou use um saco de dormir como arrasto.

Dica de segurança: nunca mova uma vítima com suspeita de lesão na coluna sem imobilização adequada. Improvise uma prancha com galhos longos e firmes amarrados ao corpo. Se não for possível imobilizar e a situação for life-threatening (ex: incêndio se aproximando), mova em bloco, mantendo a coluna o mais alinhada possível.

Erro comum: tentar evacuar uma vítima grave caminhando, piorando lesões. Se a vítima não pode caminhar, improvise transporte. Use a técnica de arrasto (puxar pela gola ou mochila), carregamento em piggyback (para vítimas conscientes e leves), ou maca improvisada com 2 galhos e uma lona/corda.

// SOBRE O LIVRO

PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES EXTREMAS

Em um mundo imprevisível, saber como agir pode fazer toda a diferença. "Primeiros Socorros em Situações Extremas" é o seu guia essencial para momentos de crise, preparando você para agir com calma e eficiência quando mais precisa. Este livro ensina as técnicas fundamentais para lidar com emergências em ambientes desafiadores, como acidentes na natureza, desastres naturais ou situações de isolamento. Com linguagem clara e direta, Clodoaldo C. Silva desmistifica procedimentos complexos, capacitand

// CONTINUE SUA JORNADA

VISITE A LOJA

Equipamentos táticos, ferramentas e gear essencial.

centrodesobrevivencia.vercel.app/equipamentos
→

APP BÚSSOLA

Manual do Sobrevivente — bússola tática no seu bolso.

manual-do-sobrevivente.vercel.app →

AUTOR: Clodoaldo C Silva

CATEGORIA: Primeiros Socorros

EDITAL: CENTRO DE SOBREVIVÊNCIA — 2026

LEIA NA PLATAFORMA: <https://centrodesobrevivencia.vercel.app>